

**SERIE D'EXERCICES POUR LES REVISIONS DE SOINS INFIRMIERS EN
PATHOLOGIES CHIRURGICALES.**

**NIVEAU LICENCE 2 IDE /REVISION POUR RATTRAPE DE
CREDITS DE LICENCE 2 IDE DES ETUDIANTS EN LICENCE
3 IDE**

Ce document a été conçu dans le but d'aider les étudiants de la licence 2 IDE et ceux de la licence 3 IDE qui ont des rattrapages en chirurgie de faire leur révisions. Ils peuvent l'imprimer pour étudier.

C'est gratuit !

Il est strictement interdit de le commercialiser.

Par conséquent, tout (e) étudiant (e) qui sera coupable de vente de ce document, sera traduit en conseil de discipline.

**Auteur : M. N'GORAN Kouamé Frédéric,
enseignant à l'INFAS, membre de la
cellule de chirurgie.**

1. OCCLUSIONS INTESTINALES

1. Quelle est la différence fondamentale entre une occlusion fonctionnelle (ou iléus) et une occlusion mécanique

- A. L'occlusion fonctionnelle nécessite toujours une intervention chirurgicale d'urgence contrairement à l'occlusion mécanique
- B. L'occlusion mécanique est due à un obstacle, tandis que l'occlusion fonctionnelle est due à une paralysie du péristaltisme
- C. L'occlusion fonctionnelle ne concerne que le gros intestin
- D. Seule l'occlusion mécanique présente une douleur abdominale

2. Lequel de ces signes cliniques constitue la triade classique de l'occlusion intestinale, en plus de la douleur abdominale?

- A. La diarrhée profuse et rectorragie
- B. Polyurie et polydipsie
- C. Vomissements, arrêt des matières et des gaz, et météorisme abdominal
- D. Fièvre, frissons et sueurs

3. Dans une occlusion du grêle par strangulation (comme une bride), pourquoi l'intervention chirurgicale est-elle une urgence absolue?

- A. Pour limiter la formation de gaz dans l'estomac
- B. Pour prévenir la nécrose ischémique de l'anse intestinale
- C. Parce que le patient ne peut plus s'alimenter
- D. Pour éviter la survenue de diabète de type 2

4. Quel examen d'imagerie est aujourd'hui l'examen de référence (gold standard) pour diagnostiquer et localiser une occlusion ?

- A. l'IRM cérébrale
- B. La radiographie du thorax
- C. Le scanner (TDM) abdomino-pelvien avec injection
- D. L'échographie cardiaque

5. En tant d'IDE, quel est le but principal de la pose d'une sonde naso-gastrique (SNG) en aspiration chez un patient occlus?

- A. Accélérer le transit intestinal vers le rectum
- B. Décompenser le tube digestif en amont de l'obstacle et soulager les vomissements
- C. Mesurer le PH gastrique toutes les heures
- D. Permettre l'administration de médicaments par voie orale

6. Quelle complication métabolique majeure est redoutée chez un patient présentant des vomissements abondants dus à une occlusion haute

- A. Acidose métabolique par rétention de gaz
- B. Hypoglycémie sévère
- C. Déshydratation avec troubles ioniques (hypokaliémie, hyponatrémie)
- D. hypercalcémie

2. Cancer du côlon

1. Lequel de ces signes cliniques est considéré comme un signe d'alerte majeur du cancer du côlon ?

- A. Une modification récente du transit intestinal
- B. Une dysurie
- C. Une douleur scapulaire
- D. Un pyrosis chronique

2. Quelle est la principale complication aigue révélatrice d'un cancer du côlon?

- A. Occlusion intestinale
- B. Infarctus du mésentère
- C. Hémorragie cataclysmique
- D. Pancréatite aigue

3. Lors d'une chirurgie avec création d'une stomie digestive, comment appelle-t-on l'abouchement du côlon à la peau?

- A. Colostomie
- B. Gastrectomie
- C. Iléostomie
- D. uroscopie

4. Quel conseil nutritionnel est prioritaire pour prévenir le cancer colorectal ?

- A. Favoriser une alimentation riche en fibres (fruits, légumes, céréales)
- B. Boire uniquement de l'eau gazeuse
- C. Augmenter la consommation de viande rouge
- D. Supprimer totalement les graisses

5. Un IDE surveille une stomie à J1. Quel aspect doit l'alerter immédiatement?

- A. Une stomie rouge et humide
- B. Une stomie noire et grisâtre
- C. Une présence de gaz dans la poche
- D. Une stomie légèrement œdémateux

3. Péritonite

1. Quel est le signe clinique pathognomonique (caractéristique) d'une péritonite généralisée?

- A. Diarrhée profuse
- B. Une hyperthermie à 40°C
- C. Une ecchymose péri-ombilicale
- D. La contracture abdominale

2. Quelle est la cause la plus fréquente des péritonites secondaires?

- A. l'insuffisance rénale
- B. La cirrhose hépatique
- C. La pancréatite aiguë
- D. L'appendicite rompue

3. Lorsqu'une péritonite est suspectée, quelle est la première action infirmière à mettre en œuvre?

- A. Mettre le patient à jeun strict
- B. Donner un antalgique per os (par la bouche)
- C. Administrer un léger repas pour éviter une hypoglycémie
- D. Pratiquer un lavement évacuateur

4. Quel est l'examen d'imagerie qui est considéré comme le GOLD standard pour diagnostiquer une péritonite aujourd'hui

- A. L'IRM cérébrale
- B. L'échographie cardiaque
- C. Le scanner abdomino-pelvien par injection
- D. La radiographie pulmonaire

5. Que signifie la présence d'un pneumopéritoine sur une imagerie?

- A. Une infection urinaire sévère
- B. La présence d'air dans la cavité péritonéale
- C. Un excès de sang dans l'abdomen
- D. Une accumulation de liquide lymphatique

6. Parmi les complications suivantes, laquelle représente le risque vital immédiat d'une péritonite?

- A. Une perte de l'appétit
- B. Un choc septique
- C. Une cicatrice inesthétique
- D. Une constipation chronique

7. En post-opératoire, quelle est la surveillance prioritaire concernant les drains (Lame ou drains de Rodon)?

- A. La quantité et l'aspect du liquide drainé
- B. La marque du fabricant du drain La couleur du sparadrap de fixation
- C. La longueur visible du tuyau à l'extérieur

8. Quel signe indique la reprise du transit intestinal en post-opératoire?

- A. Une augmentation de la diurèse
- B. Une baisse de la température
- C. L'émission de gaz
- D. L'apparition d'un soif intense

9. Pourquoi pose-t-on souvent une sonde naso-gastrique (SNG) en cas de péritonite?

- A. Pour mesurer la saturation en oxygène
- B. Pour administrer des médicaments solides
- C. Pour vider l'estomac et éviter les vomissements
- D. Pour hydrater le patient plus rapidement

10. Quel élément biologique reflète le mieux l'efficacité du traitement antibiotique et chirurgical ?

- A. Le groupe sanguin
- B. La diminution de la CRP et des leucocytes vers les limites de la normale

- C. Le taux de cholestérol
- D. La glycémie à jeun

4. Appendicite aigue

1. Quel est le signe clinique caractéristique de l'appendicite lors de la palpation de la fosse iliaque droite?

- A. Le point de Trosier
- B. Le signe de Murphy
- C. Le signe de Homans
- D. Le point de McBurney

2. Parmi les examens biologiques suivants, lequel est systématiquement recherché pour confirmer un syndrome inflammatoire?

- 3. NFS pour une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
- 4. Créatinine
- 5. Taux d'hémoglobine
- 6. La glycémie

3. Quelle complication majeure de l'appendicite se manifeste par une contracture abdominale généralisée (ventre de bois)?

- A. L'abcès appendiculaire
- B. La péritonite généralisée
- C. La colique néphrétique
- D. La plastron appendiculaire

4. En pré-opératoire immédiat pour une appendicectomie, quelle est la priorité infirmière ?

- A. Effectuer un lavement évacuateur
- B. Maintenir le patient à jeun strict
- C. Administrer une alimentation hyper-protéinée
- D. Réaliser un lever précoce

5. Quelle position peut aider à soulager spontanément la douleur d'un patient souffrant d'appendicite?

- A. Position en chien de fusil (cuisses fléchies)
- B. Position de Trendelenburg
- C. Position debout prolongée
- D. Position décubitus dorsal strict

6. Quel examen d'imagerie est souvent privilégié en première intention chez l'enfant ou la femme enceinte?

- A. L'IRM
- B. Le scanner abdominal (TDM)
- C. La radiographie de l'abdomen sans préparation
- D. L'échographie abdominale

7. Dans le cadre de la surveillance post-opératoire, que signifie la reprise des gaz?

- A. Une hémorragie interne
- B. Une complication infectieuse
- C. La reprise du transit
- D. Une intolérance alimentaire

8. Que doit vérifier l'infirmier en priorité lors du premier lever du patient?

- A. La diurèse
- B. La température corporelle
- C. La présence d'une hypotension orthostatique
- D. L'état de la cicatrice

9. Cocher les signes d'une appendicite aigue typique

- ☐ Appendicite aiguë de l'adulte jeune en position iliaque droite
- B. Vomissements alimentaires
- C. Nausées
- D. Constipation
- E. Diarrhée rare

F. Epistaxis

10. Parmi les signes physiques suivants, cochez ceux correspondant à la palpation:

- A. Diminution d'amplitude des mouvements respiratoires à la fosse iliaque droite
- B. Douleur provoquée
- C. Défense ou contracture pariétale

11 . Parmi les signes physiques suivants, cochez celui correspondant à l'inspection

- A. Diminution d'amplitude des mouvements respiratoires à la fosse iliaque
- B. Douleur provoquée
- C. Défense ou contracture pariétale

5. Hernies

1. Quelle est la définition exacte d'une hernie de la paroi abdominale?

- A. La sortie d'un viscère hors de la cavité abdominale par un orifice naturel ou accidentel
- B. Une rupture brutale des muscles grands droits après un effort violent
- C. L'accumulation de liquide séreux dans le scrotum
- D. Une inflammation généralisée du péritoine suite à un traumatisme

2. Comment appelle-t-on une hernie que l'on peut réintégrée dans l'abdomen par une simple pression manuelle?

- A. Une hernie récidivante
- B. Une hernie réductible
- C. Une hernie incarcerated
- D. Une hernie étranglée

3. Quel signe est caractéristique d'une hernie simple lors de l'examen physique?

- A. Une rougeur intense et une chaleur locale
- B. Une matité absolue à la percussion de la zone

- C. Une masse battante au rythme du pouls
- D. Une tuméfaction impulsive à l'effort de toux

4. Parmi les localisations, laquelle correspond à la hernie crurale (ou fémorale)?

- A. Au niveau de la cicatrice ombilicale
- B. Au-dessus de la ligne de Malgaigne (arcade crurale)
- C. Au dessous de la ligne de Malgaigne
- D. Sur la ligne médiane entre le sternum et l'ombilic

5. Quelle est la complication la plus grave d'une hernie abdominale nécessitant une chirurgie d'urgence?

- A. l'engouement herniaire
- B. L'étranglement herniaire
- C. La récurrence post opératoire
- D. La formation d'un lipome

6. Lorsqu'un patient présente une hernie étranglée, quel syndrome clinique est souvent associé?

- A. Un syndrome occlusif (vomissements, arrêt des matières et des gaz)
- B. Un syndrome infectieux urinaire
- C. Un syndrome hémorragique
- D. Une insuffisance respiratoire aigue

7. En post-opératoire d'une cure de hernie, quel conseil infirmier est prioritaire pour éviter les récurrences?

- A. Rester strictement aliter pendant 15 jours
 - B. Reprendre une activité sportive intense dès le lendemain
 - C. Augmenter la consommation de produits laitiers
- Eviter le port de charges lourdes et les efforts de poussée pendant quelques semaines

8. Qu'est ce qu'une éventration par rapport à une hernie?

- A. c'est une hernie qui apparaît sur une cicatrice chirurgicale antérieure
- B. C'est une complication pulmonaire après une anesthésie

- C. C'est une hernie située au niveau au de l'aine
C'est une hernie congénitale présente à la naissance

9. Quel est le traitement de référence définitif pour une hernie inguinale?

- A. Un traitement antibiotique prolongé
- B. Le port d'un bandage herniaire à vie
- C. La cure chirurgicale (avec ou sans pose de prothèse /filet)
- D. La réduction manuelle quotidienne par le patient

10. Chez le nouveau-né, quelle hernie est très fréquente et disparaît souvent spontanément avant l'âge de 3 ans?

- A. La hernie inguinale étranglée
- B. L'éventration post-opératoire
- C. La hernie ombilicale
- D. La hernie crurale

11. Quels sont les trois caractéristiques anatomopathologiques des hernies de la paroi abdominale?

- A. **Trajet pariétal ou orifice herniaire**
- B. **Les enveloppes**
- C. **Le contenu**

6. Luxation de l'épaule

1. Lors de l'examen physique, quel signe caractéristique est observé en cas de luxation antérieure ?

- A Le signe du robot
- B. Le signe de l'épaulette
- C. L'ecchymose de Hennequin
- D. Le signe du tiroir

2. Quelle complication nerveuse immédiate l'infirmier doit rechercher prioritairement en cas de luxation de l'épaule?

- A. Atteinte du nerf cubital
- B. Atteinte du nerf axillaire (circonflexe)
- C. Atteinte du nerf radial
- D. Atteinte du nerf médian

3. Quelle est l'attitude antalgique classique du patient ayant une luxation de l'épaule?

- A. Le patient soutient son bras traumatisé avec sa main valide
- B. Le patient soutient son bras traumatisé avec la main valide
- C. Le bras en élévation maximale au-dessus de sa tête
- D. Le bras ballant le long du corps sans soutien
- E. Le bras en extension complète derrière le dos

4 Pourquoi est-il crucial pour l'infirmier de vérifier le pouls radial avant toute manipulation?

- A. Pour éliminer une lésion de l'artère axillaire
- B. Pour vérifier l'état d'hydratation
- C. Pour diagnostiquer une fracture associée
- D. Pour mesurer la tension artérielle

5. Quel est l'examen primordial pour le diagnostic de la luxation de l'épaule ?

- A. Un scanner sans injection
- B. Une radiographie de l'épaule (face et profil)
- C. Une IRM de l'épaule
- D. Une échographie ostéo-articulaire

6 Une fois la réduction effectuée, quelle est la surveillance infirmière immédiate?

- A. Surveiller la disparition de la douleur et l'état neuro-vasculaire
- B. Encourager le patient à porter des charges lourdes
- C. Vérifier la reprise de la mobilité active totale

7 Parmi les complications tardives, laquelle est la plus fréquente chez le sujet jeune?

- A. La récurrence (épaule instable)

- B. L'infection articulaire
- C. L'arthrose précoce
- D. La paralysie définitive du bras

8 Quel conseil de sortie l'infirmier doit –il donner au patient immobilisé

- A. Pratiquer des mouvements d'abduction
- B. Enlever l'attelle pour dormir
- C. Mobiliser uniquement le coude, le poignet et les doigts
- D. Ne jamais bouger

7. Traumatisme du thorax

1. Quel signe cliqué est caractéristique d'une respiration paradoxale lors d'un volet costal?

- A. Une toux sèche persistante
- B. L'enfoncement du segment mobile à l'inspiration et sa saillie à l'expiration
- C. Une expansion symétrique de la cage thoracique à l'inspiration
- Une apnée prolongée en fin d'expiration

2. Lors de la surveillance infirmière d'un polytraumatisme du thorax, que signifie la disparition du choc de pointe à la palpation ?

- A. Un épanchement pleural ou péricardique important
- B. Une simple fatigue musculaire du patient
- C. Une amélioration de la fonction cardiaque
- D. Une position assise prolongée

3. Cocher les étiologies probables du traumatisme du thorax

- A. Accidents de la voie publique
- B. Accident de travail
- C. Accident de sport
- D. Agressions
- E. Rixes
- F. Toutes les réponses sont correctes exceptée la réponse E

4. Le thorax est constitué d'un contenant et d'un contenu:

VRAI

FAUX

5. Le choc de pointe ou choc apexien est la vibration perçue à la palpation lors de la systole, correspondant à l'impact de la pointe du cœur contre la paroi thoracique: VRAI FAUX

6. En cas de traumatisme du thorax, l'inspection permet d'apprécier:

- A. La coloration des téguments
- B. Le rythme respiratoire
- C. Rechercher l'existence de lésion cutanée
- D. déformation du thorax
- E. La Toutes les réponses sont correctes à l'exception de la réponse D

7. l'examen général d'un traumatisé de thorax comporte:

- A. La prise de la TA et du Pouls
- B. La recherche de notion de traumatisme (crâne, rachis, bassin et membres)
- C. Uniquement la recherche de notion de traumatisme au niveau du thorax pour ne pas perdre le temps.

8. Le volet costal est une fracture grave de la cage thoracique, survenant lorsque au moins trois côtes adjacentes sont cassées en deux endroits , créant un segment « flottant »: VRAI FAUX

9. La respiration paradoxale ou balancement thoraco-abdominal est une anomalie ventilatoire où l'abdomen se creuse à l'inspiration et se gonfle à l'expiration (inverse du mouvement naturel) VRAI FAUX

10. Dans une suspicion de traumatisme du thorax, quelle position favorise le confort respiratoire du patient conscient?

- A. Décubitus dorsal strict sans oreiller
- B. Position assise ou demi-assise

- C. Position latérale de sécurité sur le côté sain
- D. Position de Trendelenburg (tête basse)

11. Qu'est ce que l'emphysème sous cutanée?

- A. Une accumulation de sang sous la peau
- B. La présence de l'air dans les tissus mous créant une crépitation
- C. Une inflammation des muscles intercostaux
- D. Une infection cutanée

8. Fracture de la clavicule

1. Quel est le mécanisme de survenue le plus fréquent pour une fracture de la clavicule?

- A. Compression thoracique latérale
- B. Extension forcée du cou
- C. Mouvement de torsion du bras
- D. Chute directe sur l'épaule

2. Où se situe statistiquement la majorité des traits de fracture de la clavicule?

- A. Au tiers moyen (corps de l'os)
- B. Au tiers interne (sternal)
- C. Au niveau de l'articulation scapulo-humérale
- D. Au tiers externe (acromial)

3. Lors de l'examen clinique initial, quel signe est caractéristique d'une fracture déplacée de la clavicule ?

- A. Une attitude de traumatisé du membre supérieur
- B. Un signe de tiroir
- C. Une rotation interne forcée irréductible
- D. Une main creuse

4. Quel est le traitement orthopédique de référence pour une fracture non déplacée de la clavicule?

- A. Mise en traction continue
- B. Plâtre thoraco-brachial
- C. Réduction manuelle sous anesthésie générale

D. Bandage en huit ou simple échar

5. Quelle surveillance infirmière est spécifique lors du port d'anneaux en « 8 » ou bandage en « 8 »?

- A. Mesure de la pression veineuse centrale
- B. Surveillance de la diurèse
- C. Surveillance de la température rectale
- D. Surveillance du pouls radial et de la sensibilité des doigts

9. Fracture de la clavicule

1. Quel est le mécanisme de survenue le plus fréquent pour une fracture de la clavicule?

- A. Compression thoracique latérale
- B. Extension forcée du cou
- C. Mouvement de torsion du bras
- D. Chute directe sur l'épaule

2. Où se situe statistiquement la majorité des traits de fracture de la clavicule?

- A. Au tiers moyen (corps de l'os)
- B. Au tiers interne (sternal)
- C. Au niveau de l'articulation scapulo-humérale
- D. Au tiers externe (acromial)

3. Lors de l'examen clinique initial, quel signe est caractéristique d'une fracture déplacée de la clavicule ?

- A. Une attitude de traumatisé du membre supérieur
- B. Un signe de tiroir
- C. Une rotation interne forcée irréductible
- D. Une main creuse

4. Quel est le traitement orthopédique de référence pour une fracture non déplacée de la clavicule?

- A. Mise en traction continue
- B. Plâtre thoraco-brachial
- C. Réduction manuelle sous anesthésie générale

Bandage en huit ou simple écharpe

5. Quelle surveillance infirmière est spécifique lors du port d'anneaux en « 8 » ou bandage en « 8 »?

- A. Mesure de la pression veineuse centrale
- B. Surveillance de la diurèse
- C. Surveillance de la température rectale

Surveillance du pouls radial et de la sensibilité des doigts

10. Fractures de l'humérus

1 les trois types de fractures de l'humérus sont?

- A. Les fractures du corps de l'humérus
- B. Les fractures supra condyliennes
- C. Les fractures de l'olécrâne (coude)
- D. Les fractures de l'os zygomatique

2 LES étiologies des fractures de l'humérus sont:

- A. Choc direct
- B. Torsion indirecte
- C. Cas d'accident de la voie publique
- D. Chute sur le coude

3 les signes fonctionnels d'une fracture de l'humérus sont;

- A. La douleur
- B. Impotence fonctionnelle

C. Raccourcissement du membre

4 les signes physiques d'une fracture de l'humérus sont:

- A. Crépitation à la palpation du membre
- B. Œdème ou tuméfaction et décoloration locale de la peau
- C. Raccourcissement du membre
- D. La douleur lancinante

5. LA CONTRACTURE DE Volkmann ou SYNDROME DE Volkmann est

Est une complication orthopédique grave et redoutée, qui survient généralement à la suite d'un traumatisme du membre supérieur (fracture de l'humérus, ou de l'avant bras) VRAI FAUX :

11. Fracture des 2 os de l'avant-bras

1. **Quelle est la définition exacte d'une fracture des deux os de l'avant-bras?**
 - 2. A. Une fracture touchant uniquement la tête du radius
 - 3. Une fracture de l'extrémité distale du radius uniquement
 - 4. Une solution de continuité des diaphyses du radius et de l'ulna
 - 5. Une fracture de l'ulna associée à une luxation de deux os longs constituant l'avant-bras

2. Lors de l'examen clinique initial, quel signe est caractéristique d'une fracture déplacée des deux os de l'avant-bras?

- A. Une attitude vicieuse avec angulation et impotence fonctionnelle totale
- B. Une simple limitation de la pronosupination
- C. Une déformation en dos de fourchette
- D. Une simple ecchymose sans douleur

3. Les signes fonctionnels en cas de fracture des deux os de l'avant-bras sont:

- A. l'impotence fonctionnelle complète
- B. La douleur
- C. La déformation

4. Les signes physiques sont:

- A. La déformation
- B. L'œdème

5. Caractéristiques de cette déformation:

- A. De face, il y a décalage
- B. De profil, une angulation à sommet postéro-externe
- C. Formation d'un cercle

6 que précise la radiographie ?

- A. Le trait de fracture
- B. Le déplacement
- C. Le chevauchement
- D. La rotation

7 les fractures des enfants sont très souvent incomplètes. Elles sont dites:

- A. En herbes vertes
- B. En bois vert
- C. En bois
- D. Fractures compliquées

8. la fracture de Pouteau Colle est celle de la partie distale du radius ou fracture classique juxta-articulaire , fréquente et survient généralement à a suite d'une chute sur la main à plat . Elle se produit chez les personnes âgées qui souffrent d'ostéoporose,

VRAI

FAUX

9 A la palpation l'IDE découvre:

- A. Douleur au niveau du trait de fracture
- B. Crépitation à la palpation
- C. Raccourcissement du membre
- D. Les fragments osseux

10 la consolidation de la fracture des deux os de l'avant-bras se fait généralement entre 40 et 50 jours sauf en cas de complication

• VRAI

FAUX

11 La complication immédiate est:

- A. le syndrome de Volkmann
- B. Le cal vicieux
- C. Les pseudarthroses
- D.

12 les complications tardives sont:

- A. le syndrome de Volkmann
- B. Les cals vicieux
- Les pseudarthroses

13 Rôle de l'infirmier dans la surveillance d'un plâtre consiste à :

- A. Rechercher une main gonflée et violacée (cyanose)
- B. Une froideur des extrémités
- C. Signaler pour que le plâtre soit fendu ou enlever au moindre doute
- D. Se contenter à prendre les constantes

14 Devant tous symptômes alarmant chez un blessé plâtré, l'IDE doit enlever toute compression et prévenir le chirurgien

VRAI

FAUX

15. Une surveillance infirmière sous plâtre doit vérifier l'absence de quel signe?

- A. Une chaleur normale des téguments
- B. Une démangeaison passagère
- C. Une légère odeur de plâtre humide
- D. Des fourmillements (paresthésie) ou une froideur des doigts

16. Pourquoi il est crucial de laisser les doigts libres lors de la pose d'un plâtre pour l'avant-bras,

- A. Parce que les doigts ne se fracturent jamais en même temps
- B. Pour éviter que le plâtre ne soit trop lourd
- C. Pour permettre aux doigts de continuer à écrire
- D. Pour surveiller la sensibilité, la motricité et la vascularisation

17. Quel conseil d'éducation est prioritaire pour un patient porteur d'une attelle ou d'un plâtre en post-traumatique?

- A. Passer des aiguilles à tricoter sous le plâtre pour gratter
- B. Surélever le membre pour favoriser le retour veineux et limiter l'œdème
- C. Ne jamais bouger les doigts
- D. Mouiller régulièrement le plâtre pour le refroidir

18. Que signifie le terme « réduction » d'une fracture?

- A. Diminuer la dose d'antalgique
- B. Enlever le plâtre avant la date prévue
- C. Remettre les fragments osseux dans leur alignement anatomique normal
- D. Raccourcir l'os pour qu'il cicatrise plus vite

12. Fracture du poignet

1 Quel est le mécanisme traumatique le plus fréquent d'une fracture de Pouteau Colle?

- A. Une chute sur la paume de la main
- B. Une chute sur le dos de la main en flexion
- C. Un choc direct sur le coude
- D. Une torsion violente de l'avant-bras

2 Quelle déformation caractéristique observe-t-on de profil lors d'une fracture de Pouteau Colle?

- A. Une saillie de tête de l'ulna uniquement
- B. Une déformation en dos de fourchette
- C. Une déformation en ventre de fourchette
- D. Une déformation en coup de hache externe

3. Quelle déformation caractéristique observe-t-on de face lors d'une fracture de Pouteau Colle?

- A. Une déformation en « baïonnette »
- B. Une déformation en dos de fourchette
- C. Une déformation en dos de cuillère

4 Quel examen d'imagerie est indispensable pour confirmer le diagnostic :

- A. Une IRM du poignet
- B. Une échographie ostéo-articulaire
- C. Une radiographie du poignet face et profil
- D. Un scanner sans injection

5. Quelle structure nerveuse risque d'être compressée au niveau du poignet lors de cette fracture?

- A. Le nerf médian ou cubital
- B. Le nerf radial
- C. Le nerf ulnaire
- D. Le nerf masculo-cutané

6. Quelle est la complication cutanée spécifique à surveiller sous un plâtre trop serré?

- A. Le purpura
- B. L'eczéma de contact
- C. L'escarre sous plâtre
- D. Le prurit physiologique

• **7. le syndrome de Volkmann est dû à une double fautes thérapeutiques qui sont:**

- A. Plâtre trop serré et non fendu à temps
- B. Doigts non surveillés
- C. Conjonctives non surveillées

8. La phase immédiate du syndrome de Volkmann comporte une ischémie de la main et des doigts VRAI FAUX

9. LA PHASE secondaire du syndrome de Volkmann comporte une rétraction ischémique des fléchisseurs de la main , des doigts et la paralysie du médian et du cubital VRAI FAUX

10. La phase de séquelle apparait vers le 6^{ème} mois VRAI FAUX

11 Parmi les complications tardives , laquelle se manifeste par des douleurs , un œdème et une raideur inexpliquée?

- A. LE SYNDROME DE Volkmann
- B. La pseudarthrose
- C. La calvitie précoce
- D. L'algodystrophie

12. Quel est le but principal d'une ostéosynthèse par plaque vissée?

- A. Diminuer le temps de cicatrisation cutanée
- B. Assurer une réduction parfaite et une stabilité immédiate
- C. Eviter la rééducation

Remplacer l'os par du métal définitivement

13 Quel est l'os du carpe le plus fréquemment fracturé lors d'une chute sur la main?

- A. L'os crochu (hamatum)
- B. Le scaphoïde
- C. Le trapèze
- D. Le lunatum

14. Où se situe la douleur élective évocatrice d'une fracture du scaphoïde?

- A. Sur la face palmaire du poignet, côté auriculaire
- B. Dans la tabatière anatomique

Au niveau de 2^{ème} phalange de

15 les signes cliniques suspectant une fracture au niveau du carpe sont;

- A. Vive douleur à la mobilisation du pouce
- B. Œdème de la tabatière anatomique
- C. Douleur à la flexion axiale du pouce
- D. Point douloureux précis sous la styloïde radiale
- E. Mouvement de latéralité douloureux du poignet
- F. Douleur cardiaque

16. Ces signes obligent l'examineur à faire un examen d'imagerie pour confirmer le diagnostic. Quel est cet examen?

- A. Radiographie face et profil
- B. IRM
- C. ASP

17 Comment s'appelle l'immobilisation plâtrée spécifique pour le scaphoïde?

- A. Un simple bandage élastique
- B. Une manchette prenant la première phalange du pouce

- C. Une minerve
- D. Un baudens
- E. Un spica

18. Quel est le rôle infirmier prioritaire lors de la pose d'une manchette plâtrée?

- A. Lui conseiller d'utiliser une tige pour se gratter sous le plâtre
- B. Aider le patient à choisir la couleur du plâtre
- C. Lui dire de ne jamais bouger les doigts
- D. Vérifier la coloration de l'extrémité des doigts

13. CONDUITE A TENIR AUPRES D'UN TRAUMATISE DES VOIES PUBLIQUES

1 Les gestes à proscrire auprès d'un traumatisé des voies publiques sont:

- A. La précipitation
- B. L'empoignement sous les aisselles
- C. Examen clinique du traumatisé d'une AVP
- D. Maintien du rachis cervical en rectitude

2. Les gestes salvateurs en cas de traumatisme des voies publiques sont:

- A. La précipitation
- B. Le fait d'assurer la liberté des voies respiratoires
- C. Soins des membres

Maintien du rachis cervical en rectitude

3. En arrivant sur les lieux d'un AVP, quelle est votre première action?

- A. Extraire la victime du véhicule
- B. Sécuriser la zone (balise, feux de détresse)

- C. Appeler immédiatement le SAMU
- D. Vérifier si la victime respire
- A. **4. Une victime consciente est coincée dans sa voiture. Quelle consigne de sécurité est primordiale concernant sa mobilité?** Lui demander de s'allonger sur le siège
- B. Lui demander de ne pas bouger la tête
- C. Lui demander de sortir pour vérifier ses reflexes
- D. L'aider à détacher sa ceinture de sécurité

3. En arrivant sur les lieux d'un AVP, quelle est votre première action?

- A. Extraire la victime du véhicule
- B. Sécuriser la zone (balise, feux de détresse)
- C. Appeler immédiatement le SAMU
- D. Vérifier si la victime respire

4. Une victime consciente est coincée dans sa voiture. Quelle consigne de sécurité est primordiale concernant sa mobilité?

- A. Lui demander de s'allonger sur le siège
- B. Lui demander de ne pas bouger la tête
- C. Lui demander de sortir pour vérifier ses reflexes
- D. L'aider à détacher sa ceinture de sécurité

5. Face à une hémorragie externe abondante sur un membre d'une victime d'AVP, quelle est la première mesure à prendre?

- A. Appliquer une pression manuelle directe
- B. Poser une attelle
- C. Désinfecter la plaie
- D. Prendre la tension artérielle

6. Vous êtes IDE, vous arrivez sur les lieux d'un AVP. Vous voyez une victime qui gît sur le sol, inconscient mais respire normalement. Quelle est la position préconisée?

- A. Position assise
- B. Position latérale de sécurité
- C. Sur le ventre
- D. Décubitus dorsal, les jambes surélevées

7. Qu'est ce qu'un dégagement d'urgence?

- A. Le transport de la victime vers l'hôpital par un témoin
- B. Le retrait du casque d'un motard
- C. L'extraction rapide d'une victime face à un danger vital immédiat
- D. L'ouverture forcée d'une portière

8. Lors de l'examen neurologique d'une victime d'AVP, quel score est plus couramment utilisé par les professionnels de santé?

- A. Le score d'Apgar
- B. L'indice de masse corporelle
- C. L'échelle de Malampati
- D. Le score de Glasgow

9. En présence d'un motard accidenté au sol, conscient, que devez vous faire avec son casque?

- A. Lui retirer immédiatement pour qu'il respire bien
- B. Ne pas retirer le casque et maintenir
- C. Ouvrir la visière uniquement s'il est conscient
- D. Lui demander de le retirer lui même

10 Après d'un AVP, il faut toujours faire un examen générale de la victime

VRAI

14. Etats de choc

1. Quelle est la définition physiologique commune à tous les états de choc?

- A. Une insuffisance circulatoire aigue entrainant une hypoxie tissulaire
- B. Une chute brutale de la tension artérielle systolique en dessous de 80 mm Hg
- C. Une perte de connaissance immédiate due à une anémie cérébrale
- D. Une accélération du rythme cardiaque supérieure à 120 battements par minutes

• 2. Quels sont les symptômes de la phase primaire d'un état de choc?

- A. Une pâleur avec refroidissement des extrémités
- B. Une tachycardie

- C. Affaissement des veines (collabées)
- D. Instabilité de la TA
- E. Diminution du débit urinaire

3. Quel est le traitement de première intention, à administrer en urgence, dans le choc anaphylactique?

- A. l'adrénaline par voie IM
- B. Les antis histaminiques seuls
- C. Les corticoïdes par voie IV
- D. Le remplissage massif par la perfusion de SGI

4. Le traitement du choc repose sur quatre grands principes qui sont:

- A. Rétablir une perfusion tissulaire correcte
- B. Le traitement doit être précoce que possible sous peine de devenir inefficace
- C. Le traitement de l'état de choc et de la lésion responsable de celui-ci, sont étroitement liés
- D. Tout blessé déchoqué reste choquable
- E. Toutes les réponses sont correctes excepté la réponse D

5. Toute manipulation avant que le sujet ait été déchoqué est à proscrire

- F. VRAI FAUX

6. Dans quel état de choc le remplissage vasculaire (perfusion) est-il généralement contre-indiqué ou doit –il être pratiqué avec une extrême prudence?

- A. Choc anaphylactique
- B. Choc sceptique
- C. Choc hypovolémique
- D. Choc cardiogénique

15. Fracture de la rotule ou patella

1. Quel est le signe clique caractéristique d'une fracture de la rotule avec déplacement des fragments?

- A. Une flexion irréductible du genou

- B. Une rotation externe du membre inférieur
- C. Une ecchymose périnéale
- D. Une impossibilité totale d'extension active de la jambe

2. Lors de l'examen physique, la perception d'un vide entre deux fragments osseux au niveau du genou est appelée;

- A. Le choc rotulien
- B. Le signe de la marche de l'escalier
- C. La dépression interfragmentaire ou le diastasis rotulien
- D. Le signe du rabot

3. Quel est l'examen radiologique de première intention pour confirmer une fracture de la rotule?

- A. Scanner (TDM) avec reconstruction en 3D
- B. IRM du genou
- C. Échographie ostéo-articulaire
- D. Radiographie du genou face, profil et défilé fémoro-patellaire

15. Le polytraumatisé

1. Quelle est la définition exacte d'un patient polytraumatisé?

- A. un patient présentant au moins deux fractures des membres
- B. Un blessé présentant plusieurs lésions dont une au moins met en jeu le pronostic vital à court terme.
- C. Une victime d'AVP, avec perte de conscience
- D. Un patient ayant subi un choc à haute cinétique sans lésion apparente

2, Un polytraumatisé est aussi appelé polyfracturé

VRAI

FAU

3. Quelle est la règle d'or pour l'abord vasculaire chez un polytraumatisé?

- A. Deux voies veineuses périphériques de gros calibre (G14 ou G16)
- B. Poser une voie veineuse centrale immédiatement
- C. Attendre l'arrivée au bloc opératoire pour perfuser

D. Une seule voie de petit calibre pour éviter de léser les veines

4. **Chez les blessés sans détresse majeure**, il faut se méfier de possibles aggravations brutales et toujours veiller à disposer d'une part, d'un abord veineux permettant un débit important et d'autre part, d'une réserve de sang suffisante. **VRAI** **FAUX**

5 Dans la lutte contre la détresse circulatoire d'un polytraumatisé, l'utilisation d'un cathéter du système cave supérieur est nécessaire dans la mesure où il permet:

- A. Les prélèvements sanguins (groupages)
- B. La surveillance de la pression veineuse centrale
- C. Les perfusions et les transfusions
- D. Toutes les réponses sont correctes exceptée la réponse B

6. Lors de la manipulation d'un polytraumatisé pour les examens du dos, quelle technique doit être utilisée?

- A. la rotation segmentaire (membre par membre)
- B. Le retournement « en monobloc » avec maintien de l'axe
- C. Demander au patient de se tourner seul s'il est conscient
- D. Utiliser un lave-malade électrique

16. Fractures des deux os de la jambe

1. Quelle la définition anatomique exacte d'une fracture des deux os de la jambe?

- A. Une fracture touchant uniquement le tiers moyen du tibia
- B. une lésion traumatique touchant le fémur et le tibia
- C. Une fracture articulaire du pilon tibial uniquement
- D. Une fracture qui se produit au –dessous du genou, touchant le tiers inférieur du tibia ou du péroné

2. Les signes physiques d'une fracture des deux os de la jambe sont:

- A. Œdème avec hématome
B. Tissus mous endommagés

Douleur

3. Les complications immédiates d'une fracture des deux os de la jambes sont:

- A. Ouverture secondaire de dedans en dehors
- B. Lésions vasculaires
- C. Lésions nerveuses : rares

17. Le polytraumatisé

1. Quelle est la définition exacte d'un patient polytraumatisé?

- A. un patient présentant au moins deux fractures des membres
- B. Un blessé présentant plusieurs lésions dont une au moins met en jeu le pronostic vital à court terme.
- C. Une victime d'AVP, avec perte de conscience
- D. Un patient ayant subi un choc à haute cinétique sans lésion apparente

2. Un polytraumatisé est aussi appelé polyfracturé

VRAI

FAUX

3. Quelle est la règle d'or pour l'abord vasculaire chez un polytraumatisé?

- A. Deux voies veineuses périphériques de gros calibre (G14 ou G16)
- B. Poser une voie veineuse centrale immédiatement
- C. Attendre l'arrivée au bloc opératoire pour perfuser
- D. Une seule voie de petit calibre pour éviter de léser les veines

4 Chez les blessés sans détresse majeure, il faut se méfier de possibles aggravations brutales et toujours veiller à disposer d'une part, d'un abord veineux permettant un débit important et d'autre part, d'une réserve de sang suffisante. VRAI

FAUX

5 Dans la lutte contre la détresse circulatoire d'un polytraumatisé, l'utilisation d'un cathéter du système cave supérieur est nécessaire dans la mesure où il permet:

- A. Les prélèvements sanguins (groupages)

- B. La surveillance de la pression veineuse centrale
- C. Les perfusions et les transfusions
- D. Toutes les réponses sont correctes excepté la réponse B

6. Lors de la manipulation d'un polytraumatisé pour les examens du dos, quelle technique doit être utilisée?

- A. la rotation segmentaire (membre par membre)
- B. Le retournement « en monobloc » avec maintien de l'axe
- C. Demander au patient de se tourner seul s'il est conscient
- D. Utiliser un lave-malade électrique

18. TRAUMATISMES DES MENISQUES

1. Quel est le mécanisme lésionnel le plus fréquent lors d'une fracture traumatique du ménisque chez un sujet jeune?

- A. Une flexion forcée avec rotation interne du fémur sur un tibia fixe
- B. Une compression axiale pure
- C. Une extension brutale et répétée du genou
- D. Un choc direct sur la face antérieure de la rotule

2. Lequel de ces signes est considéré comme pathognomonique (caractéristique) d'une lésion méniscale en anse de seau?

- A. l'épanchement de synovie immédiat
- B. Le blocage vrai du genou en flexion
- C. Une instabilité lors de la marche en terrain plat

Le symptôme le plus fréquent dans les traumatismes est:

- A. Le blocage
- B. Le claquement et sensation de déchirure
- C. Ressaut articulaire
- D. La douleur

4. Pourquoi la zone blanche du ménisque (interne) cicatrise-t-elle très difficilement par rapport à la zone rouge (périphérique)?

- A. Elle est soumise à trop de pression
- B. Elle st en contact avec le liquide synovial
- C. Elle est composée d'os

Elle n'est pas vascularisée

Lors de l'examen clinique, quelle manœuvre consiste à rechercher une douleur lors de l'extension du genou associée à une rotation du genou?

- A. le test de Hawkins
- B .Le test de Lachman
- C. Le signe du tiroir antérieur
- Le test ou la manœuvre le McMururray

19. CANCER DU RECTUM

1. Quel est le signe clinique le plus fréquent (maître symptôme) évocateur d'un cancer du rectum?

- A. La fièvre prolongée
- B. Les douleurs lombaires
- C. La perte de poids brutale
- D. Les rectorragies

2. Quel est l'examen clinique simple, réalisable en consultation , permet de palper une tumeur située dans le bas rectum ?

- A. La percussion de l'aire hépatique

- B. La palpation abdominale
- C. L'auscultation des bruits hydro-aériques
- D. Le toucher rectal

3. Dans le cadre d'une amputation abdomino-périnéale, quelle est la conséquence définitive pour le patient?

- A. Une colostomie gauche définitive
- B. Un régime sans résidus à vie
- C. Une sonde urinaire à demeure
- Une iléostomie provisoire

4. Sur le plan infirmier, quelle est la priorité de surveillance immédiate en post-opératoire d'une chirurgie rectale?

- A. l'administration de la chimiothérapie
- B. La capacité du patient à marcher
- C. Le choix de l'appareillage définitif
- D. La reprise du transit et l'aspect de la stomie

5. Lorsqu'une stomie digestive est d'aspect noirâtre ou grisâtre à J1, que cela signifie-t-il?

- A. Une irritation normale due à l'appareillage
- B. Un effet secondaire de l'anesthésie
- C. La présence normale de selles méconiales
- D. Une nécrose de la stomie par ischémie

20. Cancer du rein

1. Quelle est la triade clinique classique (bien que rare car tardive) du cancer du rein?

- A. polyurie, polydipsie et protéinurie
- B. Dysurie, pollakiurie et fièvre
- C. Hématurie, douleur lombaire et masse palpable
- D. Oligurie, œdème et hypertension

2. Dans le cadre de la surveillance infirmière post-opératoire, - immédiate d'une néphrectomie, quel paramètre est crucial pour évaluer la fonction du rein restant?

- A. La diurèse horaire
- B. La saturation en oxygène
- C. La température corporelle
- D. Le périmètre abdominal

3. Quel est le principal facteur de risque environnement reconnu pour le cancer du rein?

- A. La sédentarité
- B. La consommation de café
- C. Le tabagisme
- D. L'exposition au soleil

21. Cancer de l'estomac

1. Quel bactérie est reconnue comme un facteur de risque majeur et direct du cancer de l'estomac (ou gastrique) ?

- A. Escherichia coli
- B. Clostridium difficile
- C. Staphylococcus aureus
- D. Helicobacter pylori

2. Parmi les signes cliniques suivants, lequel est un signe d'appel fréquent mais tardif du cancer de l'estomac?

- A. Une polydipsie
- B. Une toux sèche
- C. Des céphalées
- D. Une épigastralgie persistante

3. Quel examen est considéré comme l'examen de référence pour diagnostiquer un cancer de l'estomac?

- A. La prise de sang (marqueur tumoraux)

- B. Le scanner (TDM) thoraco-abdominaux-pelvien
- C. L'échographie abdominale
- D. L'endoscopie oeso-gastroduodénale (EOGD) avec biopsie

3. Dans le bilan d'extension, que recherche-t-on avec le scanner

- A. Le type de bactérie présente
- B. La capacité de stockage de l'estomac
- C. Le taux d'acidité gastrique
- D. La présence de métastases (foie, poumons, péritoine)

5. Dans le cas du cancer de l'estomac, le traitement le plus efficace est la chimiothérapie.

VRAI

FAUX

6. Le seul traitement du cancer de l'estomac est le traitement chirurgical.

VRAI

FAUX

7. Qu'est ce que le Dumping syndrome après une gastrectomie?

- A. Une vidange gastrique trop rapide vers l'intestin grêle
- B. Une occlusion intestinale haute
- C. Une carence en vitamine B12
- D. Une infection de la cicatrice opératoire

9. Quels sont les soins infirmiers per-opératoires lors d'une gastrectomie?

- A. Préparer la chambre du malade : refaire le lit, prévoir une potence vérifier les sources d'aspiration, d'oxygène.
- B. Quantifier l'apport et les pertes liquidiennes (perfusion, urines, etc.)
- C. L'infirmier doit s'assurer s'il existe une surveillance particulière à exercer
- D. Le pouls, la tension artérielle (TA), la température (T°)

10. Après une gastrectomie, pour éviter le reflux biliaire, l'IDE doit:

- A. Faire manger le patient en position assise
- B. Eviter la sieste horizontale
- C. Faire manger le patient en position demi-assise

11. Quel est le risque principal immédiat surveillé par l'IDE en post-opératoire d'une gastrectomie?

- A. L'hémorragie post-opératoire
- B. Le risque de constipation
- C. La perte de poids
- D. L'alopécie

22. Traumatisme du bassin

1 Quelles sont les complications immédiates dans un traumatisme du bassin?

- A. Un choc hémodynamique
- B. Lésion de l'urètre
- C. Lésion de la vessie
- D. Lésion du rectum
- E. Lésions nerveuse
- F. Ouverture cutanée

2. Quelle est la complication immédiate la plus redoutée lors d'un traumatisme du bassin?

- A. Lésion de l'urètre
- B. Lésion de la vessie
- C. Un état de choc hémodynamique
- D. Lésion du rectum

3. lors de l'examen clinique, quel signe peut faire suspecter une lésion urétrale associée?

- A. Une polyurie
- B. Une hématurie macroscopique
- C. Une douleur lombaire
- D. Une uretrorragie

4. Quelle position doit être évitée chez un patient suspect de fracture du bassin non stabilisée?

- A. Le décubitus latéral

- B. La mise en déclive (Trendelenburg)
- C. Le décubitus dorsal strict
- D. La position demi-assise

5. Quelle est la complication thromboembolique particulièrement redoutée lors d'un alitement prolongé pour fracture du bassin?

- A. la thrombose veineuse profonde (phlébite)
- B. L'AVC
- C. Infarctus du myocarde
- D. L'anémie ferriprive

23. Fractures de la diaphyse du fémur

1 Quelle est la principale étiologie des fractures de la diaphyse du fémur?

- A. Les Rixes
- B. Les AVP
- C. Les travaux champêtres
- D.

2. Quelle est la complication immédiate la plus redoutable lors d'une fracture de la diaphyse fémorale?

- A. Le choc hémorragique
- B. L'embolie graisseuse
- C. L'infection

3 le traitement de la fracture de la diaphyse fémorale est essentiellement chirurgical. VRAI FAUX

4 les Signes fonctionnels d'une fracture de la diaphyse fémorale sont:

- A. Douleur vive au niveau de la cuisse
- B. Impotence fonctionnelle absolue
- C. Un raccourcissement de la cuisse

5 .Quel signe clinique est caractéristique d'une fracture déplacée de la diaphyse fémorale lors de l'examen initial?

- A. Un raccourcissement de la cuisse
- B. Une déformation en dos de fourchette
- C. Une rotation interne du membre

6 les signes physiques à l'inspection d'une fracture de la diaphyse fémorale montrent une déformation évidente composée de :

- A. Un raccourcissement de la cuisse
- B. Une déformation en crosse à convexité antéro-externe
- C. Une rotation externe de la jambe, le pied étant tourné en lit
- D. Un gonflement et une ecchymose de la cuisse apparaissent dans les heures qui suivent l'accident

7.L'examen clinique d'une fracture de la diaphyse fémorale doit rechercher d'éventuelles complications immédiates qui sont:

- A. Les lésions cutanées
- B. Lésions vasculaires (pouls poplitée et pédieux)
- C. Lésions nerveuses (sensibilité et mobilité des orteils)
- D. Lésions articulaires
- E. Lésions associées d'autres organes

8. Quel est l'examen d'imagerie indispensable pour une fracture de la diaphyse fémorale après immobilisation?

- A. IRM
- B. ASP
- C. Radiographie face et profil

9. Les complications immédiates en cas de fracture de la diaphyse fémorale sont;

- A. Ouverture du foyer de fracture
- B. Choc traumatique et hémorragique
- C. Lésions vasculo-nerveuses

- D. Fréquente atteinte du genou
- E. Interposition musculaire

10 . Les complications secondaires et générales en cas de fracture de la diaphyse fémorale sont:

- A. phlébite et embolie
- B. Accident de décubitus
- C. Retard de consolidation

11. Les complications tardives en cas de fracture de la diaphyse fémorale sont:

- A. Atrophie musculaire
- B. Cals vicieux
- C. Pseudarthrose
- D. Raideur du genou
- E. Toutes les réponses précédentes sont correctes excepté la réponse C

12 le traitement en urgence d'un patient ayant une fracture de la diaphyse du fémur consiste à:

- A. Immobilisation provisoire pour éviter d'aggraver le choc et minimiser le risque d'embolie graisseuse
- B. « Déchoquer » le blessé

13. Dans le cadre de la surveillance d'un patient sous traction cutanée, quel est le risque principal lié à l'installation?

- A. l'hyperthermie
- B. L'hypertension artérielle
- C. La déshydratation
- D. L'escarre au talon

14 Rôles de l'IDE sur le lieu de l'accident en cas de fracture fermée de la diaphyse fémorale:

- A. Examen clinique complet

- B. Immobilisation du membre atteint dans une attelle
- C. Administration d'antalgique
- D. Manœuvre et mobilisation pour éviter le choc
- E. Transport rapide du blessé au centre chirurgical sans tenir compte des secousses

15 Rôles de l'infirmier sur le lieu de l'accident en cas de fracture fermée de la diaphyse fémorale:

- A. Pas de manœuvre ou de mobilisations intempestives
- B. Examen clinique minutieux et complet
- C. En cas d'hémorragie abondante, clamber les vaisseaux qui saignent ou poser un garrot à la racine du membre
- D. Transport et sans précipitation du blessé au centre chirurgical

16 lors d'un traumatisme violent du fémur ; quel autre bilan lésionnel doit systématiquement être fait par l'IDE sur le lieu de l'accident?

- A. Un examen ophtalmologique
- B. Une glycémie capillaire
- C. Une vérification de l'audition
- D. Une recherche de fracture du bassin ou du col du fémur

24. ADENOME DE LA PROSTATE

1. **Quelle est la définition physiologique de l'adénome de la prostate, aussi appelé hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) ?**
 - A. une inflammation bénigne d'origine bactérienne
 - B. une atrophie progressive du tissu prostatique lié à l'âge
 - C. une prolifération maligne des cellules ganglionnaires
 - D. Une augmentation du volume de la prostate aux dépens de la zone de transition

2. Lequel de ces signes cliniques fait partie des signes irritatifs de l'adénome de la prostate ?

- A .L'attente avant le début de la miction.
- B. La diminution de la force du jet.
- C. La dysurie (difficulté à uriner).
- D. La pollakiurie nocturne.

3. Quel examen clinique simple permet au médecin d'évaluer le volume et la consistance de la prostate ?

- A. Le toucher rectal (TR).
- B. La palpation des fosses lombaires.
- C. L'auscultation abdominale.
- D. La percussion vésicale.

4. Quelle est la complication aiguë majeure de l'HBP nécessitant une prise en charge infirmière immédiate ?

- A. La rétention aiguë d'urine (globe vésical).
- B. La lithiase vésicale.
- C. L'adénocarcinome prostatique.
- D. L'insuffisance rénale chronique

5. Sur le plan biologique, quel marqueur est souvent dosé pour éliminer un cancer associé, bien qu'il puisse être modérément élevé dans l'HBP ?

- A. L'Urée sanguine.
- B. La Créatininémie.
- C. La CRP (Protéine C-Réactive).
- D. L'Antigène Prostatique Spécifique (PSA).

6. En post-opératoire immédiat d'une chirurgie de la prostate, quel est le rôle principal de l'irrigation vésicale continue par sonde à 3 voies ?

- A. Mesurer précisément la diurèse horaire.
- B. Éviter la formation de caillots sanguins qui boucheraient la sonde.

- C. Administrer des antibiotiques directement dans la vessie.
- D. Hydrater le patient par voie locale.

8. Quel signe doit alerter l'IDE lors de la surveillance des lavages vésicaux chez un opéré de la prostate ?

- A. Une égalité entre les volumes injectés et les volumes recueillis.
- B. Une urine de couleur rosée claire.
- C. Une température corporelle à 37.2 ° C.
- D. L'arrêt de l'écoulement dans le sac collecteur alors que le lavage coule.

25. RETENTION URINAIRE

1. Quelle est la définition exacte de la rétention aiguë d'urine (RAU) ?

- A. L'impossibilité totale et brutale d'émettre des urines malgré une vessie pleine.
- B. Une infection de la vessie provoquant des envies fréquentes.
- C. Une diminution de la production d'urine par les reins.
- D. Une émission involontaire d'urines pendant le sommeil.

2. Quel signe clinique est pathognomonique (caractéristique) du globe vésical lors de l'examen physique ?

- A. Une douleur à la palpation des fosses lombaires.
- B. Une contracture abdominale généralisée.
- C. Une matité à la percussion de la région hypogastrique, à convexité supérieure.
- D. Une souplesse de l'abdomen avec tympanisme péri-ombilical.

3. Quelle pathologie masculine est la cause la plus fréquente de rétention urinaire chez l'homme de plus de 60 ans ?

- A. La lithiase rénale.
- B. Le cancer de la vessie.
- C. L'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).
- D. L'orchite (inflammation des testicules).

4. Comment appelle-t-on les fuites urinaires qui surviennent lorsque la vessie est trop pleine et 'déborde' ?

- A. La miction par regorgement ou l'incontinence urinaire par regorgement (ou l'incontinence par trop-plein).
- B. La dysurie hépatique.
- C. L'incontinence d'effort.
- D. L'impériosité mictionnelle.

5. En cas d'échec de pose de sonde urinaire par voie naturelle chez un homme avec globe, quelle est l'alternative d'urgence ?

- A. Le cathétérisme sus-pubien (Cathéter de Cystocath).
- B. L'administration de diurétiques puissants.
- C. Une néphrostomie percutanée.
- D. Une cystoscopie immédiate

5. Lors du sondage vésical pour évacuer un globe, pourquoi faut-il clamber la sonde tous les 500 ml d'urine évacués ?

- A. Pour éviter une infection urinaire ascendante.
- B. Pour prévenir une hémorragie 'a vacuo' par décompression trop rapide.
- C. Pour tester la contractilité du muscle détrusor.
- D. Pour ne pas remplir le sac collecteur trop vite.

6. Quel examen d'imagerie simple et non invasif permet de mesurer le volume d'urine restant dans la vessie (le résidu) ?

- A. L'ASP (Abdomen sans préparation).
- B. Le Bladder-Scanner (échographie vésicale portable).
- C. L'IRM pelvienne.
- D. L'Urographie Intra-Vineuse (UIV).

7. Quelle est la complication rénale majeure d'une rétention urinaire chronique non traitée ?

- A. Le cancer du rein.
- B. La glomérulonéphrite aiguë.

- C. L'insuffisance rénale obstructive (par reflux).
- D. L'hypokaliémie sévère.

8. Parmi ces causes, laquelle est une étiologie fréquente du rétrécissement de l'urètre?

- A. L'utilisation de vêtements trop serrés
- B. Une carence en vitamine C
- C. Un traumatisme du bassin
- D. Une consommation excessive de sel

9. Quel geste infirmier est contre-indiqué lors d'une suspicion de rupture traumatique de l'urètre?

- A. La surveillance de la diurèse
- B. La prise de la tension artérielle
- C. La pose de cathéter sous-pubien
- E. Le sondage urinaire par voie urétrale

10. Après la levée d'un globe important, quel phénomène physiologique l'IDE doit-il surveiller de près (risque de déshydratation) ?

- A. Le syndrome de levée d'obstacle.
- B. La rétention hydrosodée.
- C. L'anurie réflexe.
- D. Le syndrome de sevrage.

26.RETRECISSEMENT DE L'URETRE

1. Quelle est la définition physiopathologique du rétrécissement urétral ?

- A. Une diminution du calibre de l'urètre due à une cicatrisation fibreuse de sa muqueuse.
- B. Une inflammation aiguë de la vessie.
- C. Une compression de l'urètre par une tumeur prostatique.
- D. Une malformation rénale congénitale.

2. Quel est le maître-symptôme révélateur d'un rétrécissement de l'urètre?

- A. La dysurie (difficulté à uriner)
- B. Une douleur lombaire brutale

- C. Une polyurie (urine abondante)
- D. Une hématurie terminale

3. Quelle est la cause iatrogène la plus fréquente d'un rétrécissement urétral ?

- A. La pratique excessive d'activités sportives.
- B. Une alimentation trop riche en sel.
- C. Le sondage urinaire traumatique ou prolongé.
- D. L'utilisation prolongée de diurétiques.

4. Quel signe clinique est le premier motif de consultation pour un rétrécissement urétral ?

- A. Une perte de poids inexpliquée.
- B. Une hématurie totale.
- C. Une douleur lombaire brutale.
- D. Une diminution progressive de la force du jet mictionnel (dysurie).

5. Comment appelle-t-on le jet urinaire lorsqu'il se divise en plusieurs filets à cause de la sténose ?

- A. Un jet bifide ou en arrosoir.
- B. Une miction par regorgement.
- C. Un jet polyurique.
- D. Un jet mictionnel explosif.

6. Quelle complication aigue nécessite une prise en charge en urgence dans un cas de rétrécissement de l'urètre?

- A. Une pollakiurie nocturne isolée
- B. La rétention complète d'urine (globe vésical).
- C. Une incontinence urinaire d'effort
- D. Une hypotension artérielle

27.L' HYDROCELE

1. Quelle est définition physiologique exacte de l'hydrocèle?

- A. Une dilatation des veines du cordon spermatique
- B. Une accumulation de sang dans la tunique vaginale
- C. une inflammation vaginale aiguë de l'épididyme et du testicule
- D. Une accumulation de liquide séreux entre les deux feuillets de la tunique vaginale

2. Lors de l'examen physique, quel signe clinique est caractéristique d'une hydrocèle simple?

- A. Une rougeur et une chaleur locale importante
- B. La trans-illumination positive du scrotum
- C. Une douleur scrotale intense et brutale
- D. La présence d'une masse scrotale non trans-illuminable

3. Quelle est la cause principale de l'hydrocèle congénitale chez l'enfant?

- A. Un traumatisme lors de l'accouchement
- B. Une infection urinaire mal soignée
- C. La présence de la communication du canal péritonéo-vaginal
- D. Une tumeur testiculaire sous-jacente

Exercices de synthèse sur l'urologie

1. Quel est le signe fonctionnel urinaire le plus caractéristique d'un adénome de la prostate?

- A. Douleur rénale bilatérale?
- B. La dysurie initiale avec jet faible
- C. L'hématurie terminale abondante
- D. L'incontinence urinaire d'effort

2. Devant une rétention aigue d'urine (RAU), quel est le signe clinique majeur retrouvé à la palpation abdominale?

- A. Une fosse iliaque droite (FID) sensible
- B. Une défense abdominale généralisée
- C. Le globe vésicale (matité sus-pubienne convexe)
- D. Un contact lombaire bilatéral

3. Quelle est la principale cause acquise du rétrécissement de l'urètre chez l'homme?

- A. une consommation excessive de sel
- B. La déshydratation chronique
- C. Les traumatismes (chutes à califourchon ou sondage traumatique)
- D. L'hypertrophie des testicules

4. Qu'est-ce qu'une hydrocèle vaginale?

- A. Une accumulation de liquide entre les feuillets de la tunique vaginale
- B. Une dilatation des veines du cordon spermatique
- C. Une infection bactérienne de l'épididyme
- D. Une tumeur maligne du testicule

5. Lors d'un sondage urinaire pour rétention aigue, quelle précaution l'IDE doit-elle prendre pour éviter une hémorragie ex-vacuo?

- A. Utiliser une sonde de très gros calibre
- B. Clamper la sonde tous 500 ml évacués
- C. Vider le plus rapidement possible
- D. Injecter de l'air dans la vessie avant

6. Quel examen simple permet de différencier une hydrocèle d'une hernie inguino-scrotale lors de l'examen clinique?

- A. La transillumination des bourses
- B. La prise de la tension artérielle
- C. L'auscultation cardiaque
- D. Le test de la bandelette urinaire

7. Quelle est la complication majeure à long terme d'un rétrécissement de l'urètre?

- A. Une hypertension artérielle maligne
- B. Une hypertrophie des glandes surrénales
- C. L'insuffisance rénale obstructive
- D. Un cancer de la prostate

8. Dans le cadre d'un adénome de la prostate, que mesure-t-on avec le score IPSS?

- A. Le taux de PSA dans le sang
- B. La vitesse de filtration glomérulaire
- C. Le volume précis de la prostate en grammes
- D. la sévérité des symptômes et la qualité de vie du patient

9. Un patient arrive avec une rétention aigue et une forte fièvre. Quelle est la contre-indication majeure?

- A. La pose d'une voie veineuse
- B. l'administration de paracétamol
- C. La réalisation d'une échographie
- D. Le sondage urinaire à demeure

10. Quel est le traitement de référence d'un rétrécissement de l'urètre ?

- A. Une cure d'antibiotiques de 6 MOIS
- B. La pose d'une prothèse mammaire
- C. L'urétrectomie interne au laser ou à la lame
- D. Le massage prostatique quotidien

Du courage à vous !